FLUJOGRAMA 4 · TRASLADO INTERHOSPITALARIO DEL TEP · CAMPDEVÀNOL → VIC / CLÍNIC

TEP confirmado o sospecha alta · categoría A–E (± R) documentada

Anticoagulación parenteral en curso: HBPM en C–D1 · HNF en D2–E o si se prevé reperfusión

▼

¿Criterio de traslado?

C3 sin box monitorizado o que empeora · D1–D2 · E · arritmia · hipoxemia no controlable con reservorio/OAF · contraindicación de anticoagulación o lisis · trombo en tránsito, FOP, embarazo · comorbilidad grave · deterioro pese a anticoagulación

no

Manejo en Campdevànol

A–C2 (y C3 con box monitorizado): apartados 4.2–4.3. Reevaluar: si empeora → D

sí

¿Categoría E (shock persistente o PCR)?

sí

FIBRINÓLISIS LOCAL ANTES DE SALIR (Flujograma 3)

Sin contraindicación absoluta:
Alteplasa (de elección) 100 mg en 2 h (10 + 90 mg; < 65 kg máx. 1,5 mg/kg) · PCR: 50 mg en bolo ± 50 mg
Tenecteplasa (disponible actualmente): bolo único por peso real (< 60 kg 30 mg · 60–69 35 · 70–79 40 · 80–89 45 · ≥ 90 kg 50 mg), fuera de ficha
Con contraindicación absoluta → PERT inmediato (catéter, embolectomía o ECMO en el Clínic)

no (C3, D1–D2)

LLAMADA AL PERT DEL CLÍNIC (≤ 30 min)

932 27 54 00 · busca 380396
D2 que empeora o traslado previsto > 60–90 min → valorar lisis local con el PERT

▼

OPTIMIZACIÓN ANTES DEL TRASLADO (A-B-C)

A · Vía aérea

- Evitar IOT (riesgo de PCR en la inducción)
- Si es imprescindible: el más experto, noradrenalina en marcha, inductor a dosis reducida (ketamina o etomidato), preoxigenación
- Vt 6 mL/kg peso ideal · PEEP baja · evitar hipoxemia e hipercapnia

B · Oxigenación

- SpO_2 ≥ 90 %: Ventimask → reservorio → OAF
- VMNI con presiones bajas (reduce la precarga del VD)
- Vasodilatadores inhalados: no

C · Circulación

- Fluidos ≤ 500 mL solo sin congestión (POCUS: VD/VCI)
- Noradrenalina 0,05–0,1 µg/kg/min y titular · dobutamina 2–10 µg/kg/min si bajo gasto con PA conservada
- 2 vías de 18 G · sin punciones no compresibles

▼

PERT: ¿necesita terapia por catéter, embolectomía o ECMO-VA?

(contraindicación o fracaso de la lisis, shock refractario, trombo en tránsito, D2 seleccionado)

sí

H. CLÍNIC (~90 min) · PERT

Catéter · embolectomía · ECMO-VA
SEM 061 · unidad SVA (valorar medio aéreo en E)

no

CHV · VIC (~30 min) — solo UCI y MI, sin intervencionismo

UCI: D2–E y post-lisis no tributario del Clínic
Medicina Interna monitorizada: D1, C3 sin box, arritmia

▼

ANTES DE SALIR · checklist SBAR

- Categoría A–E ± R, PESI/sPESI, VD/VI, troponina, NT-proBNP, lactato
- Peso y talla · fármaco, dosis y hora de HNF/HBPM y de la lisis · último TTPa
- Contraindicaciones de lisis revisadas · riesgo de sangrado
- Angio-TC accesible en HC3/PACS · ECG · informe
- Nivel de intensidad terapéutica (PIIC) · consentimiento informado
- Plan si empeora mientras espera el traslado

DURANTE EL TRASLADO

- Monitorización continua: ECG, PA (invasiva si vasoactivos), SpO_2, $EtCO_2$ si IOT
- Post-lisis: neurológico c/15 min · cefalea, sangrado (hematuria, melena, puntos de punción) → parar perfusión y avisar
- Bombas mínimas · movilizaciones mínimas · registro escrito
- **Plan de desvío**: deterioro en ruta al Clínic → UCI de Vic (en el trayecto)
- Si pasa de D a E antes de salir → lisis local primero

No retrasar el traslado por ecocardiografía, TTPa de control, segunda analítica ni ingreso administrativo. No trasladar un E sin estabilizar (AHA 2026, clase 3: daño). Fuentes: Rali P, et al. CHEST 2021;160:1844-52 · AHA/ACC 2026 · ESC 2019 · ERC 2025. Umbrales locales pendientes de consenso con el PERT del Clínic, UCI y Medicina Interna del CHV.